DOI:10.20255/j.cnki.issn1674-9561.2024.10.008

认知言语训练在儿童语言发育迟缓中的应用价值

韩　雪
（睢宁县中医院，江苏 徐州　221200）

【摘要】目的：分析语言发育迟缓患儿应用认知言语训练的效果。方法：选取2022年10月至2023年9月本院收治的语言发育迟缓患儿80例，其中40例行认知言语训练，设为观察组；40例行常规康复训练，设为对照组。比较两组语言发育水平［发育商（DQ）评分］、言语功能［汉语标准失语症检查（CRRCAE）评分］、认知和神经功能［简易精神状态检查量表（MMSE）评分、美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评分］及近期疗效。结果：观察组语言发育水平较高，言语功能、认知与神经功能较好，总有效率较高（$P<0.05$）。结论：通过认知言语训练可促进语言发育迟缓患儿语言发育，改善其言语功能，提高其认知功能、神经功能，近期疗效较好，临床价值显著。

【关键词】语言发育迟缓　认知言语训练　儿童发育障碍　言语功能

语言发育迟缓是指儿童语言理解和表达能力低于同龄人，常见诱因包括听力或者智力障碍、中枢神经系统异常、构音器官疾病及语言环境不良等[1]。语言发育迟缓发病率较高，可直接影响患儿阅读能力、理解能力和计算能力等，导致患儿生活、学习受到影响，同时影响患儿的心理健康。常规康复训练效果较差，认知言语训练是结合言语训练与认知能力训练方法，其理论基础是行为主义学习训练。认知言语训练的目的是通过言语、认知等多方面干预，促进患儿语言发育[2]。本研究从2022年10月至2023年9月本院收治的语言发育迟缓患儿中选取80例进行分组研究，分析认知言语训练的效果，评估其应用价值。

1　资料与方法

1.1　一般资料

选取2022年10月至2023年9月本院收治的80例语言发育迟缓患儿，观察组40例，男24例，女16例；年龄1.0～5.0岁，平均（3.11±0.72）岁；发育商（DQ）障碍程度：轻度障碍15例，中度障碍18例，重度障碍7例。对照组40例，男23例，女17例；年龄1.5～5.0岁，平均（3.08±0.75）岁；DQ障碍程度：轻度障碍13例，中度障碍20例，重度障碍7例。资料可予对比（$P>0.05$）。

纳入标准：①语言发育迟缓。②重要脏器功能正常。③资料完整。④右利手。

排除标准：①自闭症患儿。②先天性畸形患儿。③伴癫痫疾病患儿。④合并精神病患儿。⑤运动功能障碍患儿。⑥近期进行过同类治疗患儿。

1.2　方法

对照组行常规康复干预。①语言功能训练。使用工具训练刺激患儿听觉、触觉、视觉、语言表达能力，进行混合语言能力训练。②家长健康教育。调查评估患儿生长环境，针对患儿家庭环境对家长进行健康宣教。向家长说明语言发育迟缓的原因、发展机制和深远影响，提高家长重视度。叮嘱家长在照护患儿时适度使用电子产品，避免患儿过度屏幕暴露。指导家长使用色卡、玩具等进行日常训练。

观察组在对照组基础上行认知言语训练。

（1）认知功能训练。①视力知觉训练。使用带有光亮效果的电动玩具，以及大型黑白色卡，利用玩具、色卡吸引患儿。②听力知觉训练。使用乐器或者发声玩具作为训练道具，利用道具发出不同音频和音质的声音。训练时，道具与患儿距离15 cm左右，每次持续3～5 s，关闭声音2～3 s后再次启动音效，重复上述动作。③记忆力训练。选取患儿熟悉的玩具和物品，使用盒子、布巾等隐藏物品，鼓励患儿根据记忆位置将其找

中国知网　https://www.cnki.net

出。康复人员发出 2 步以上指令，让孩子按顺序完成。④注意力训练。引导患儿多感官感知事物和周围环境，利用带有声源、光源的工具吸引患儿注意力，训练患儿持续保持注意力。如呼名训练、目光对视、互动性游戏等。⑤视觉刺激。通过多感官训练，利用夸张动作、患儿喜欢的玩具等与患儿进行互动，在游戏互动中培养患儿视线接触习惯，提高患儿意识传递能力。

（2）语言功能训练。①手势符号训练。针对中、重度语言发育迟缓患儿，加强言语符号理解训练，提高患儿理解语言符号的能力。从简单的手势符号开始训练，以手势符号为媒介，指导患儿准确理解和传递符号，然后向言语符号的理解、使用过渡。②交流训练。在训练过程中，康复人员积极与患儿交流，使患儿熟悉、信任康复人员。③语言训练。首先练习语言理解，然后鼓励和指导患儿进行言语表达。训练从简单的字词句开始，指导患儿通过模仿逐步掌握字词句的表达方法。在训练中，指导患儿辨认日常生活中常见的事物，指导家长在日常生活中随时指导患儿进行发声训练。通过持续训练，逐渐增强患儿使用词句的能力。从名词、动词开始，循序渐进，增强患儿理解力、言语表达能力。④手部精细活动训练。引导患儿进行串珠、拇食指捏小丸、手工制作等，增强专注力，促进患儿视触觉等感知系统发育，进而促进认知和语言能力的发展，以及培养创造力和解决问题的能力。

（3）社交游戏训练。①排队玩游戏。小朋友们按顺序排好队，并记住排在谁的后面，一个小朋友在玩的时候，康复师引导其他小朋友认真看并等待，不遵守规则的小朋友不能进行下一轮的游戏。②轮流搭积木。小朋友们一起搭积木，每次一个小朋友搭一块积木，让孩子学会轮替、等待、互相帮助。

（4）音乐游戏训练。锻炼孩子的节奏感和模仿能力，感受音乐带来的乐趣，在音乐中提升专注力，提升语言认知能力。选择患儿喜欢的儿童歌曲，指导患儿配合节拍跟唱。选择简单的打击乐器，例如手鼓等，指导患儿跟随音乐节奏敲击练习。

全部患儿训练时间为 60 min/ 次，1 d 1 次，5 次 / 周，持续训练 3 个月。

1.3　观察指标

（1）对比两组语言发育水平。训练前后评估两组发育商（DQ）评分，主要包括 5 个能区，即智能发育适应性、大动作、精细动作、语言与个人 – 社交能力。DQ 评分 25 ～ 39 分为重度缺陷；DQ 评分 40 ～ 54 分为中度缺陷；DQ 评分 55 ～ 74 分为重度缺陷；DQ 评分 75 ～ 85 分为重度缺陷；DQ 评分＞ 85 分为发育正常。

（2）对比两组言语功能。康复训练前后评估两组汉语标准失语症检查（CRRCAE）评分。口头表达能力分值 1 ～ 10 分，计算能力分值 0 ～ 20 分，听力、复述能力、抄写能力、朗读能力、听写能力分值均为 1 ～ 6 分，CRRCAE 总分 60 分，评分与语言功能呈正相关。

（3）对比两组认知、神经功能。认知功能采用简易精神状态检查量表（MMSE）评估，包括定向力（0 ～ 9 分）、即刻记忆力（0 ～ 3 分）、注意和计算能力（0 ～ 5 分）、回忆能力（0 ～ 3 分）、语言能力（0 ～ 9 分），共 30 分。MMSE 评分＜ 26 分视为认知功能障碍。神经功能采用简易精神状态检查量表（NIHSS）评估，分值 0 ～ 42 分，神经功能与 NIHSS 评分呈负相关。

（4）对比两组近期疗效。①痊愈：完全纠正语言功能异常，基本恢复语言功能，DQ 评分正常。②显效：语言功能改善，DQ 评分提高 15 分以上。③有效：语言功能障碍减轻，DQ 评分提高 5 ～ 14 分。④无效：无上述改善。总有效率 =（①＋②＋③）/ 40 × 100.00 %。

1.4　统计学方法

采用 SPSS 24.0 统计学软件进行数据分析，计量资料以（$\bar{x} \pm s$）表示，采用 t 检验；计数资料以率（%）表示，采用 χ^2 检验。$P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2　结果

2.1　两组语言发育水平对比

干预前，组间 DQ 各项评分无明显差异（$P > 0.05$）；干预后，观察组 DQ 各项评分高于对照组，组间差异显著（$P < 0.05$），见表 1。

2.2　两组言语功能对比

干预前，两组 CRRCAE 各项评分无明显差异（$P > 0.05$）；干预后，观察组 CRRCAE 各项评分高于对照组，组间差异显著（$P < 0.05$），见表 2。

2.3　两组认知、神经功能评分对比

干预前，两组 MMSE、NIHSS 评分无明显差异（$P > 0.05$）；干预后，观察组 MMSE 评分高于对照组，NIHSS 评分低于对照组，组间差异显著（$P < 0.05$），见表 3。

2.4　两组近期疗效对比

观察组总有效率为 95.00%，高于对照组的 77.50%。观察组基本痊愈率为 42.50%，高于对照组

中国知网 https://www.cnki.net

表1　两组语言发育水平对比（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	n	时间	适应性	精细动作	大动作	语言	个人-社交能力
观察组	40	干预前	52.80 ± 6.04	53.24 ± 5.71	55.22 ± 6.10	54.02 ± 6.11	51.94 ± 6.26
		干预后	83.10 ± 7.62①②	82.64 ± 7.23①②	85.13 ± 7.95①②	84.09 ± 7.92①②	83.10 ± 7.29①②
对照组	40	干预前	52.77 ± 6.16	53.28 ± 5.58	55.20 ± 6.31	54.00 ± 6.26	51.91 ± 6.40
		干预后	70.67 ± 6.29①	71.98 ± 8.05①	74.09 ± 6.98①	72.15 ± 6.54①	72.67 ± 6.83①

注：与同组干预前比较，①$P<0.05$；与对照组干预后比较，②$P<0.05$。

表2　两组言语功能对比（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	n	时间	口头表达能力	听力	复述能力	抄写能力	朗读能力	听写能力	计算能力
观察组	40	干预前	2.04 ± 0.30	2.40 ± 0.31	2.91 ± 0.35	1.80 ± 0.22	2.10 ± 0.32	1.70 ± 0.23	1.30 ± 0.22
		干预后	3.62 ± 0.39①②	4.55 ± 0.47①②	4.94 ± 0.51①②	3.45 ± 0.43①②	3.80 ± 0.37①②	3.35 ± 0.32①②	4.10 ± 0.43①②
对照组	40	干预前	2.07 ± 0.28	2.42 ± 0.29	2.93 ± 0.31	1.79 ± 0.20	2.08 ± 0.30	1.71 ± 0.26	1.32 ± 0.21
		干预后	2.61 ± 0.37①	3.42 ± 0.44①	3.95 ± 0.42①	2.59 ± 0.37①	2.84 ± 0.29①	2.51 ± 0.34①	2.97 ± 0.31①

注：与同组干预前比较，①$P<0.05$；与对照组干预后比较，②$P<0.05$。

表3　两组认知、神经功能评分对比（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	n	时间	认知功能（MMSE评分）	神经功能（NIHSS评分）
观察组	40	干预前	5.06 ± 0.91	26.24 ± 3.92
		干预后	9.70 ± 1.20①②	11.07 ± 3.25①②
对照组	40	干预前	5.11 ± 0.87	26.21 ± 3.85
		干预后	7.79 ± 1.12①	18.94 ± 3.10①

注：与同组干预前比较，①$P<0.05$；与对照组干预后比较，②$P<0.05$。

的 22.50%。组间差异显著（$P < 0.05$）。

3　讨论

当前对于语言发育迟缓临床主要是明确病因，对患儿进行针对性心理干预和语言康复训练，解除病因，促进患儿语言功能恢复。认知言语训练是基于行为主义学习理论，针对患儿当前认知功能状态、语言发育水平设计实施的康复训练方案[3]。在此种康复训练中，对患儿进行认知功能训练、语言能力训练、社交游戏训练及音乐游戏训练，充分利用儿童发育黄金时期，刺激患儿认知语言系统发育[4]。与传统康复干预方法相比，认知言语训练不仅进行语言功能训练，而且给予全方位感觉统合刺激，刺激神经系统发展，干预效果显著。

本研究结果显示，观察组患儿语言发育水平更高，言语功能、认知和神经功能均更优，近期疗效更好（$P < 0.05$）。观察组康复训练期间，在言语功能刺激的同时提高感知统合能力，开展认知训练、手功能训练、交流训练，提高社会适应性，提高语言学习和应用能力，因此患儿认知、神经功能与言语功能均显著改善，最终观察组患儿疗效更佳。

综上所述，采用认知言语训练方法可提高语言发育迟缓患儿语言发育水平，提高患儿言语功能、认知功能及神经功能，促进疗效提升，应用效果较好。

【参考文献】

[1] 陈寒昱，田莉莉，白云磊，等．儿童语言发育迟缓的影响因素及综合干预的疗效研究［J］．中国妇幼健康研究，2022，33（9）：7-13．

[2] 吴素华，毕圣洁．游戏结合言语训练在2～5岁语言发育迟缓患儿康复护理中的应用［J］．中外医学研究，2022，20（8）：104-107．

[3] 庞慧．游戏结合言语训练在2～5岁语言发育迟缓高危儿童康复护理中的应用效果［J］．中西医结合护理（中英文），2021，7（10）：82-84．

[4] 周灵芝，刘倩，梁伟健．游戏辅以言语训练在语言发育迟缓患儿康复护理的效果评价［J］．护士进修杂志，2021，36（18）：1720-1722．

中国知网　https://www.cnki.net